

5 Blutwerte, die jede Frau kennen sollte

Werte, die im Standard-Blutbild häufig fehlen, obwohl sie viel über Energie, Schilddrüse und Stoffwechsel verraten. Kurz erklärt, mit dem üblichen Laborbereich und einem engeren Zielbereich, wie ihn Fachleute für Präventivmedizin empfehlen.

KOSTENLOSER LEITFADEN

Unauffällig heißt nicht optimal versorgt

Ein Laborbereich bildet ab, welche Werte in einer großen, gemischten Bevölkerung häufig vorkommen, nicht was für deinen Körper gut funktioniert. Ein Wert kann also formal „im Normbereich“ liegen und trotzdem am unteren oder oberen Rand dessen, was du als Energie und Wohlbefinden spürst.

Ein Beispiel: Der Körper leert bei Eisenmangel zuerst seine Speicher (Ferritin), lange bevor sich das im klassischen roten Blutbild zeigt. Ferritin „im Normbereich“ schließt einen beginnenden Mangel deshalb nicht sicher aus.

Die folgenden fünf Seiten zeigen zu jedem Wert den Bereich, den viele Labore als unauffällig führen, und daneben den engeren Zielbereich, den einzelne Ärztinnen und Fachleute der Präventivmedizin in ihrer Praxis verwenden. Das ist eine Orientierung für das Gespräch mit deiner Ärztin, keine Diagnose und keine Handlungsaufforderung ohne ärztliche Rücksprache.

1

Schritt eins

Dein letztes Blutbild heraussuchen oder beim nächsten Termin gezielt danach fragen.

2

Schritt zwei

Die eigenen Werte mit beiden Spalten der Tabellen vergleichen, nicht nur mit dem Laborbereich.

3

Schritt drei

Auffälligkeiten mit deiner Ärztin besprechen, bevor du etwas veränderst.

Ferritin

Eisenspeicher

Ferritin ist das Speicherprotein für Eisen. Es ist die erste Reserve, aus der der Körper schöpft, lange bevor ein Eisenmangel im roten Blutbild sichtbar wird.

HÄUFIGER LABORBEREICH

ab etwa 8 bis 30 ng/ml, je nach Labor

ENGERER ZIELBEREICH

über 50 ng/ml

MÖGLICHES ALLTAGSSIGNAL

Anhaltende Erschöpfung oder Haarausfall trotz eines formal unauffälligen Blutbilds.

Wichtig für die Einordnung: Ferritin ist zugleich ein Akute-Phase-Protein und steigt bei Entzündungen unabhängig vom Eisenstatus. Ein niedriger Wert ist deshalb aussagekräftiger als ein hoher, und gehört immer im Zusammenhang mit dem CRP-Wert betrachtet.

Quelle: DeLoughery TG, „Sex, lies, and iron deficiency: a call to change ferritin reference ranges“, Hematology Am Soc Hematol Educ Program, 2023;2023(1):617–622 (physiologische Eisen-Rückkehr zur Baseline und Rückgang von Erschöpfungssymptomen erst ab einem Ferritin-Wert über 50 ng/ml, in mehreren zitierten Studien).

TSH

Schilddrüsen-Steuerhormon

TSH wird in der Hirnanhangdrüse gebildet und regt die Schilddrüse zur Hormonproduktion an. Steigt TSH deutlich an, meldet das oft, dass die Schilddrüse zu wenig Hormon produziert.

HÄUFIGER LABORBEREICH

etwa 0,5 bis 4,0 mIU/l

ENGERER ZIELBEREICH

rund 1,0 mIU/l, Obergrenze etwa 2,5

MÖGLICHES ALLTAGSSIGNAL

Müdigkeit, Kälteempfinden oder Gewichtsveränderungen trotz eines TSH-Werts, der noch im Laborbereich liegt.

TSH allein zeigt nur einen Ausschnitt. Für ein vollständigeres Bild gehören die freien Schilddrüsenhormone fT3 und fT4 dazu, die bei einer Routineuntersuchung nicht automatisch mitbestimmt werden.

Quelle: Pearce SH et al., „2013 ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism“, European Thyroid Journal, 2013;2(4):215–228 (allgemeiner Referenzbereich 0,4 bis 4,0 mIU/l, empfohlener Zielbereich bei Behandlung in der unteren Hälfte, 0,4 bis 2,5 mIU/l).

Vitamin D

25-OH-D3

Vitamin D ist fettlöslich und wirkt weit über den Knochenstoffwechsel hinaus, unter anderem auf das Immunsystem. Der Körper speichert es über Wochen, ein einzelner Wert zeigt daher die Versorgung über einen längeren Zeitraum.

HÄUFIGER LABORBEREICH

Mangel unter 20 ng/ml, Insuffizienz 21 bis 29 ng/ml

ENGERER ZIELBEREICH

zuverlässig über 30 ng/ml, einzelne Fachleute diskutieren höhere Werte bei Autoimmunthemen

MÖGLICHES ALLTAGSSIGNAL

Erhöhte Infektanfälligkeit oder Erschöpfung, vor allem in den lichtärmeren Monaten.

Für ein aussagekräftiges Ergebnis sollte der Bluttest nicht direkt nach einer hochdosierten Einnahme erfolgen. Ein Abstand von etwa vierzehn Tagen zur letzten Einnahme gilt als gängige Praxis, da das Vitamin fettlöslich ist und lange nachwirkt. Werte über 100 ng/ml werden ausschließlich unter ärztlicher Kontrolle angestrebt, nicht in Eigenregie.

Quelle: Holick MF et al., „Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline“, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011;96(7):1911–1930 (Mangel unter 20 ng/ml, Insuffizienz 21 bis 29 ng/ml, empfohlenes Behandlungsziel zuverlässig über 30 ng/ml). Ein höherer Zielbereich speziell bei Autoimmunerkrankungen wird in der Praxis einzelner Fachleute diskutiert, ist aber durch keine offizielle Leitlinie mit konkreten Zahlen belegt.

Cortisol

Tagesrhythmus statt Einzelwert

Cortisol ist das zentrale Stresshormon und folgt einem festen Tagesrhythmus. Ein einzelner Blutwert zeigt nur eine Momentaufnahme, aussagekräftiger ist der Verlauf über den Tag.

ZEITPUNKT

kurz nach dem Aufwachen

TYPISCHER VERLAUF

deutlicher Anstieg (Aufwachreaktion)

ZEITPUNKT

Mittag bis Nachmittag

TYPISCHER VERLAUF

stetiger Abfall

ZEITPUNKT

gegen 23 bis 24 Uhr

TYPISCHER VERLAUF

Tiefpunkt

MÖGLICHES ALLTAGSSIGNAL

Einschlafprobleme trotz Erschöpfung oder ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Süßem am Abend.

Zur Einordnung, weil der Begriff viel in sozialen Medien kursiert: Eine allgemeine „Nebennierenschwäche“ lässt sich nach einer systematischen Übersicht über 58 Studien nicht belegen. Ein einzelner Speicheltest ersetzt keine ärztliche Abklärung. Halten Beschwerden an, lohnt sich die Suche nach einer konkreteren Ursache, etwa der Schilddrüse, einem Eisenmangel oder dem Schlaf.

Quelle: Cadegiani FA, Kater CE, „Adrenal fatigue does not exist: a systematic review“, BMC Endocrine Disorders, 2016;16:48 (58 ausgewertete Studien, keine Bestätigung von „Nebennierenschwäche“ als eigenständigem Krankheitsbild).

Homocystein

Spiegel der B-Vitamin-Versorgung

Homocystein ist eine Aminosäure, die im Stoffwechsel laufend entsteht und mithilfe von Vitamin B6, B12 und Folat wieder abgebaut wird. Der Wert gehört nicht zum Standardpanel und wird meist nur bei gezieltem Verdacht bestimmt.

HÄUFIGER LABORBEREICH

als unauffällig geführt bis etwa 15 $\mu\text{mol/l}$

ENGERER ZIELBEREICH

etwa 4 bis 8 $\mu\text{mol/l}$, steigendes Risiko bereits ab 6 bis 7 $\mu\text{mol/l}$ diskutiert

MÖGLICHES ALLTAGSSIGNAL

Ein niedriger, gut eingeordneter Wert ist meist Ausdruck eines gut versorgten B-Vitamin-Stoffwechsels, kein Zufallsbefund.

Bei einer bekannten MTHFR-Genvariante wird die B-Vitamin-Versorgung ärztlich anders eingeordnet als ohne diese Variante, das gehört in ein persönliches Gespräch, nicht in eine allgemeine Checkliste.

Quelle für den Zielbereich: allgemeine Angaben zu Homocystein und B-Vitamin-Stoffwechsel aus der internen Wissensgrundlage von Präventum, Stand August 2026.

ZUM SCHLUSS

Was diese Checkliste zeigt, und was sie nicht ersetzt

Diese Seiten sind eine Orientierung für dein nächstes Arztgespräch, keine Diagnose. Sie basieren auf öffentlich zugänglichem Fachwissen und den Einschätzungen der genannten Ärztinnen und Autoren.

Kristin Oelmann ist Ernährungstrainerin (A- und B-Lizenz) und Fitnesstrainerin (B-Lizenz), keine Ärztin. Diese Checkliste ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Behandlung, sie kann ein Gespräch mit deiner Ärztin sinnvoll vorbereiten.

Nimm bei anhaltenden Beschwerden, unabhängig vom Ergebnis dieser Checkliste, ärztlichen Rat in Anspruch.

ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN

60 Minuten online, Fokus Blutbild-Auswertung

praeventum-kristinoelmann.netlify.app/erstgesprach.html